



ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE

↳ Mais negros
↳ Baixa renda
↳ Homens

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESCVI



↳ Doenças → Pneumonia / Tuberculose
IS7

↳ Risco de contaminação
↳ Mudança de cela

OBJETIVOS:

1. *Conhecer os objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).*
2. *Conhecer a atenção à saúde da População Privada de Liberdade.*
3. *Abordar os princípios da Atenção Básica na população prisional.*
4. *Abordar a avaliação clínica na admissão no presídio.*
5. *Conhecer os problemas específicos relacionados à população prisional.*
6. *Conhecer as Equipes de Atenção Básica Prisional (EABP).*

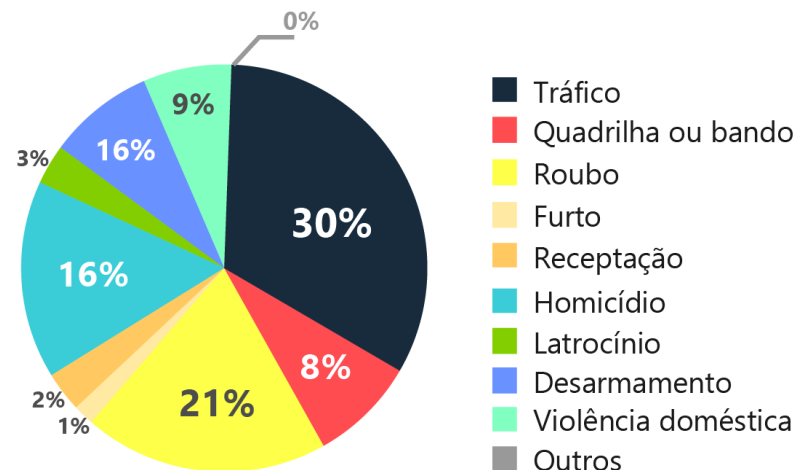
- De acordo com os dados de 2014, a população prisional brasileira chegou a 607.731 pessoas.

↗ Desatualizados

□ Desde 2000, a população prisional cresceu, em média, 7% ao ano.

↗ Mais pessoas presas do que fora

- A maioria são homens jovens, de baixa escolaridade cumprindo pena principalmente por roubo, tráfico de drogas, furtos e homicídios.



- Essa população, oriunda na maioria das vezes de comunidades desfavorecidas, já apresenta condições de saúde precárias antes mesmo do encarceramento.
- Condições de higiene inadequadas, celas mal ventiladas e superpopulosas contribuem para o agravamento da sua condição de saúde.



- Nessas condições, a instituição de medidas diagnósticas e terapêuticas específicas pode ser benéfica não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade em geral.



POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP)

- Oferece ações de promoção da saúde e prevenção de agravos no sistema prisional, em todo o itinerário carcerário para toda a população privada de liberdade, e também para os profissionais destes serviços penais, familiares e outras pessoas relacionadas ao sistema, como voluntários.
- Para o alcance desta política, entendemos por sistema prisional todo o itinerário carcerário, desde o momento da detenção do cidadão e sua condução para um estabelecimento policial até a finalização do cumprimento da pena.

- Entende-se por pessoa privada de liberdade no sistema prisional os indivíduos maiores de 18 anos custodiados em unidades prisionais (excluem-se os tutelados pelo Sistema Nacional Socioeducativo - Sinase).



- Na população do sistema prisional é possível encontrar grande pluralidade:
 - ❑ Homens jovens, em sua maioria; estrangeiros; idosos; mulheres; crianças (filhos dessas mulheres privadas de liberdade) e populações vulneráveis, como indígenas, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, pessoas com transtornos mentais e com deficiências.

- Todos os tipos de agravos em saúde que acometem a população geral também são encontrados no sistema prisional, mas podem ser potencializados devido às condições precárias de confinamento de grande parte das unidades prisionais e também à superlotação.
- As pessoas privadas de liberdade, apesar da perda do direito de ir e vir conservam seus demais direitos fundamentais, que deverão ser protegidos e garantidos pelo Estado.
- O direito à saúde está garantido pela Constituição Federal, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo marco legal que regulamenta este.



- Tais dispositivos indicam a Atenção Básica como ordenadora desse Sistema.

↳ PNAISP

- Isso significa que, com a PNAISP, as unidades prisionais passarão a ser “portas de entrada” e “ponto de atenção” da Rede de Atenção à Saúde.
- Os serviços serão formados por equipes de atenção básica prisional (EABP), que organizarão a saúde intramuros na perspectiva da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e seguimento, permitindo que essa população, mediante regulação do SUS, tenha acesso aos serviços de urgências e emergências, à atenção especializada e hospitalar na rede extramuros, sempre que houver necessidade de atenção de maior complexidade.



OBJETIVO GERAL DA PNAISP

- Garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS.

Garantir o acesso à saúde



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover o acesso das pessoas privadas de liberdade à Rede de Atenção à Saúde, visando ao cuidado integral;
2. Garantir a autonomia dos profissionais de saúde para a realização do cuidado integral das pessoas privadas de liberdade;
3. Qualificar e humanizar a atenção à saúde no sistema prisional por meio de ações conjuntas das áreas da saúde e da justiça;
4. Promover as relações intersetoriais com as políticas de direitos humanos, afirmativas e sociais básicas, bem como com as da Justiça Criminal;
5. Fomentar e fortalecer a participação e o controle social.

PRINCIPAIS AÇÕES DA PNAISP

- Garantir o acesso à Rede de Atenção à Saúde no território com mais agilidade, equidade e qualidade.
- Promover ações para promoção de doenças e prevenção de doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis e dos agravos decorrentes do confinamento.
- Melhorar as ações de vigilância sanitária na alimentação e nas condições de higiene dentro das unidades prisionais e para garantir a salubridade ambiental.
- Operar estendendo e aprofundando as ações de todos os programas do Ministério da Saúde.

- Atuar na prevenção do uso de álcool e de drogas e na reabilitação de usuários.
- Garantir medidas de proteção, como a vacinação para hepatites, influenza e outras do calendário de adultos.
- Garantir ações de promoção de saúde bucal (ex.: palestras, escovação e avaliação bucal) e tratamento.
- Garantir o acesso aos programas de saúde mental, gerais e específicos.
- Garantir aquisição e repasse de medicamentos da farmácia básica às equipes de Saúde e distribuição de insumos (preservativos, absorventes, entre outros) para as pessoas presas.
- Multiplicar as unidades básicas de saúde prisional e promover o seu funcionamento na lógica do SUS.

EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA PRISIONAL (EABP)

- Os serviços e equipes serão definidos de acordo com os seguintes critérios:
 1. Número de pessoas privadas de liberdade por unidade prisional;
 2. Vinculação dos serviços de saúde a uma unidade básica de saúde no território;
 3. Existência de demandas referentes à saúde mental.



TIPOS DE EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NO SISTEMA PRISIONAL (EABP):

Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I (EABP I)

- Apresenta uma composição mínima que conta com um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, um cirurgião dentista e um técnico ou auxiliar de saúde bucal.

↓ Med, ↓ enfermeiro, ↓ dentista ↓ auxiliar de saúde bucal

- Essa equipe deverá atender até 100 pessoas privadas de liberdade e cumprir carga horária mínima de 6 horas semanais.

100 pessoas no presídio - 6 horas semanais

- ❑ Esses profissionais podem ser provenientes da Estratégia de Saúde da Família do território, fato que não causará incompatibilidade de jornadas de trabalho, pois o Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde identifica a carga horária desses profissionais como “Carga Horária Diferenciada”, ou seja, não haverá soma de cargas horárias.

Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II (EABP II)

- Cujas composição mínima inclui um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem, um cirurgião dentista, um técnico ou auxiliar de saúde bucal, um psicólogo, um assistente social e um profissional de nível superior dentre as seguintes ocupações: fisioterapia, psicologia, assistência social, farmácia, terapia ocupacional, nutrição ou enfermagem.

Mesmo do tipo I + psicólogo + assistente social + ^{↳ Se suicídio ↑} Nutricionista
↳ Fisioterapeuta
↳ Farmacêutico

- Essa equipe deverá atender de 101 a 500 pessoas privadas de liberdade e cumprir o mínimo de 20 horas semanais, ficando a cargo do gestor a distribuição da carga horária de cada profissional, não podendo ser inferior a 10 horas semanais.

100 - 500 presos — 20 horas semanais, todos devem ter no

mínimo 10 horas semanais

- Às EABP I e II poderá ser acrescentada uma equipe de saúde mental, a depender do perfil epidemiológico da Unidade Prisional.

□ Esta equipe de saúde mental consiste em, no mínimo, um médico psiquiatra (ou médico com experiência em saúde mental) e dois profissionais selecionados entre as seguintes ocupações: fisioterapia, psicologia, assistência social, farmácia, terapia ocupacional ou enfermagem.

Equipe de Atenção Básica Prisional tipo III (EABP III)

- Terá o mesmo perfil da EABP II acrescida, necessariamente, da equipe de saúde mental.

↳ Obrigatório ter equipe de saúde mental

- Essa equipe deverá atender de 501 a 1.200 pessoas privadas de liberdade e cumprir o mínimo de 30 horas semanais, ficando a cargo do gestor a distribuição da carga horária de cada profissional, não podendo ser inferior a 10 horas semanais.

↳ 500 - 1200 pessoas

↳ 30 horas semanais

- Os estados, o Distrito Federal e os municípios que aderirem à PNAISP, cadastrarem suas EABP no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e habilitarem no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de Saúde – SAIPS estarão aptos a receber o incentivo financeiro de custeio mensal, que será transferido pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.

PRINCÍPIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA POPULAÇÃO PRISIONAL

❖ ACESSO

- Apesar da proximidade de poucos metros das celas, a comunicação e o contato entre detentos e equipe de saúde nem sempre são facilitados.
- Dependendo do nível de segurança da unidade prisional, existem diferentes possibilidades de como o detento pode solicitar atendimento ou medicamentos.

[illegible]

Por escrito

Problemas não clínicos podem ser resolvidos sem a necessidade de consulta presencial

A documentação começa com o pedido

Referências/encaminhamentos podem ser feitos diretamente para o serviço correto, se necessário

Ações que vão abordar o problema mais diretamente podem ser agendadas (renovação de prescrições, educação em saúde, agendamento para exames, etc.)

O prontuário e outras informações podem ser revisados, permitindo uma melhor abordagem da queixa

Reduz o volume de movimento para e da unidade de saúde

Problemas de saúde que deveriam ser resolvidos de modo presencial podem ser abordados inapropriadamente

O volume de papel a ser arquivado no prontuário aumenta, uma vez que cada pedido escrito gera

um novo pedaço de papel

Uma baixa capacidade de escrita pode atrapalhar uma resposta adequada da equipe de saúde

As solicitações devem ser colocadas em uma caixa e a confidencialidade deve ser protegida

As solicitações devem ser coletadas diariamente

Maiores chances de erro ou omissão de informação importante no pedido

Prisioneiros solicitarão atendimento pela mesma queixa diversas vezes, a menos que haja uma resposta rápida e satisfatória ao paciente

Membros da equipe de saúde podem ser muito rígidos e insistir que um pedido escrito seja produzido quando o paciente deveria ser visto de qualquer maneira, mesmo que não tenha feito nenhum pedido



Consulta agendada

Aproxima-se do modelo da solicitação de consulta da comunidade em geral

Elimina a triagem e o encaminhamento ao profissional de saúde

O prontuário pode ser analisado antes da consulta

Não depende da capacidade de escrita do paciente

As consultas podem ser documentadas cronologicamente em folhas de evolução

O movimento para e da unidade de saúde é agendado

Não há priorização de necessidades e uso dos recursos

Encontros frente a frente não são necessários do ponto de vista clínico para cada problema de saúde

Pode não ser possível abordar completamente o problema, porque a informação precisa ser checada ou acompanhada

Pode haver mais solicitações do que vagas e o acesso pode ser negado

A menos que se organizem oportunidades de cancelamento do pedido, o número de ausências pode ser um problema



❖ INTEGRALIDADE

- Os serviços de atenção à saúde prisional devem garantir a integralidade, com uma carteira de serviços pelo menos semelhante à dos serviços de medicina de família e comunidade.
- Alguns cuidados adicionais são ainda necessários, como a questão de detentos que precisam de cuidadores.
- Devido às dificuldades de transporte a outros níveis de atenção na comunidade, deve haver um esforço para ampliar as capacidades de cuidado clínico "in loco", assim como serviços em áreas remotas.
 - ❑ Isso é possível trazendo profissionais externos ou aparelhos de diagnóstico para o presídio, ou ainda firmando parcerias com outros níveis de referência.

- Quanto aos medicamentos, podem ocorrer obstáculos pelo pessoal de segurança em relação a quais medicamentos podem ficar com o paciente.

- ❑ É importante que o médico negocie, dentro do possível, a favor da melhor solução clínica.

- Dependendo do porte da penitenciária, o médico também tem o dever de advogar condições adequadas de internação em hospitais gerais e terciários.

- ❑ Enfermarias adaptadas garantem tanto uma acomodação adequada ao detento quanto a segurança geral ao hospital, como, por exemplo, em relação a fugas ou resgates.

❖ COORDENAÇÃO DO CUIDADO

- O confinamento do indivíduo facilita a coordenação do cuidado nos diferentes níveis de atenção à saúde.
- São conhecidos os dias e os horários de consultas ambulatoriais referenciadas, permitindo inclusive que o próprio médico do presídio acompanhe o detento à determinada consulta, discutindo diretamente o caso com o especialista focal.
- Em muitos casos, trazer a visão das especificidades do ambiente carcerário é importante na definição da conduta, como na realização de quimioterapia ou de recuperação pós-operatória.

- Em alguns casos, o médico pode procurar diretamente os outros níveis de cuidado do sistema de saúde, sem que isso envolva necessariamente a ida presencial do detento.
- ❑ Manejos de doenças em portadores de vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite C, tuberculose e diabetes mellitus tipo 1 podem ser auxiliados remotamente pela referência, com bons resultados.
- Em geral, a contrarreferência de alguma forma está sempre garantida, visto que eventuais documentos, como receitas, exames solicitados e tratamentos propostos, retornam necessariamente à equipe de saúde da unidade prisional.

❖ LONGITUDINALIDADE

- Como no Brasil não há pena de prisão perpétua, a população prisional por definição é transitória.
- O eventual retorno à comunidade costuma ser um momento crítico na continuidade do tratamento de doenças crônicas e em recaídas em dependentes químicos.

AVALIAÇÃO CLÍNICA NA ADMISSÃO AO PRESÍDIO

↳ Identificar doenças que o preso tem antes de ir ao cárcere

- A população prisional necessita de identificação de diversas condições de saúde no momento da entrada no sistema prisional, mas nem sempre há implementação sistemática de uma avaliação inicial.
- Isso não é importante apenas para as próprias pessoas detidas e os trabalhadores do sistema prisional, mas também para as comunidades para onde eventualmente retornarão.
- Idealmente, deve haver uma unidade de porta de entrada centralizada para cada sistema prisional.

- Deve haver prioridade na pronta avaliação de condições em que a interrupção do tratamento é crítica, como diabetes em uso de insulina; dependência química cuja síndrome de abstinência pode trazer risco de morte, como o álcool; e doenças de transmissão via aérea, como a tuberculose.
- Para a população feminina, além da triagem usual, devem ser oferecidos testes de gravidez a todas as mulheres com menos de 55 anos, na admissão e sempre que solicitados.
- Doenças infecciosas são de destacada importância, haja vista a maior prevalência e o risco de transmissão: HIV, hepatites virais crônicas B e C, sífilis e tuberculose pulmonar.

↳ Teste de gravidez < 55 anos



PROBLEMAS ESPECÍFICOS

❖ TUBERCULOSE

- Na prática diária, o limiar de suspeição clínica deve ser menor.
- A estratégia de tratamento diretamente observada é difícil de ser implementada integralmente.
- Quanto à investigação de contatos, as frequentes mudanças de celas tornam esse procedimento inerentemente falho, mas deve ser realizado pelo menos naqueles que compartilham a cela no momento do diagnóstico.
- Para além do manejo clínico e ações de rastreamento, deve haver preocupação com as questões arquitetúrais.
 - ❑ São necessários esforços no sentido de se advogar melhorias estruturais que interfiram na transmissão da tuberculose – ventilação, incidência solar, superlotação – e também de capacidade diagnóstica da unidade de saúde – laboratório para análise de escarro e sala de radiografia.



❖ MEDICAÇÕES PSICOTRÓPICAS

- A demanda por benzodiazepínicos, assim como na comunidade, é bastante alta.
- Queixas de quadros de insônia primária são bastante frequentes, o que poderia trazer o impulso de tratamento farmacológico.
- O fato é que as condições do cárcere não favorecem a higiene do sono, mas, ainda assim, o uso de benzodiazepínicos e hipnóticos é bastante desencorajado.
- O potencial de abuso, em uma população já com alta prevalência de transtornos de uso de substâncias, soma-se a esse contexto.
- Extrapolando em todos os medicamentos psicotrópicos, a indicação sempre deve ser bastante criteriosa, devido aos riscos de intoxicação, ao uso indiscriminado, à simulação e ao comércio de medicamentos.

❖ SIMULAÇÃO

- É comum a simulação de sintomas mentais e neurológicos, especialmente alucinações e crises convulsivas.
- O intuito geralmente é obter medicação com potencial real ou esperado de abuso e/ou de efeito hipnótico, para uso próprio ou comércio entre os demais detentos.



❖ COMPORTAMENTOS DISRUPTIVOS

- Um fenômeno particular do confinamento são os comportamentos disruptivos – notadamente autolesão –, mas também quebrar canos das celas, sujar-se de fezes ou causar incêndios.
- Os episódios de autolesão não costumam ter intenção suicida, muitas vezes sendo descritos como uma tentativa de “extravasar” a tensão.

❖ TABAGISMO

- É um importante problema na área da saúde prisional, não apenas pelos seus efeitos adversos nos fumantes ativos, mas também nos passivos.
- As prisões fazem parte dos últimos locais fechados onde fumar ainda é permitido no mundo ocidental.
- O fumo passivo representa sérios riscos para a saúde dos que não fumam.
 - ❑ Não há limiar mínimo de exposição livre de riscos; medidas como separar fumantes de não fumantes e de ventilação são insuficientes ou impraticáveis na maioria das situações.
 - ❑ O problema é particularmente agravado em prisões, em razão da alta prevalência de tabagismo, da superlotação e da má ventilação.

❖ QUESTÕES LEGAIS

- O médico trabalhando no sistema prisional pode ter de se manifestar e até provocar o sistema judiciário por questões de saúde que podem interferir na capacidade de cumprimento da pena pela pessoa.
- Em casos de doença mental grave que se manifesta após o cumprimento da pena, dependendo da capacidade instalada de cuidados em saúde mental, ele pode acionar o instituto da superveniência de doença mental.
 - ❑ Na medida de segurança, o detento é transferido para alas psiquiátricas penais especiais.
- Em cenários de doenças graves, o médico da unidade pode provocar ou ser provocado a opinar sobre a capacidade da unidade de prover os cuidados de saúde necessários e também acerca do prognóstico.

Referências Bibliográficas

ROCHADEL, A.; MOURA R. J. População prisional. In: GUSSO, Gustavo; LOPES, José M.C.; DIAS, Lêda C. (Orgs.). **Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática**. Porto Alegre: ARTMED, 2019, p. 2388. Cap. 62.

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Disponível em: <http://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/Cartilha-PNAISP.pdf>.



Obrigada!